INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 6

Medicina estética corporal

© Copyright INESBE. Todos los derechos reservados.

Propietario INESBE - Dinam Soluciones SL. CIF B67725960 www.inesbe.com

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de este material, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión ni difusión de este material por medios electrónicos (incluyendo email, redes sociales y cualesquiera otros sistemas de transmisión informática entre particulares), mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, sin la autorización previa y por escrito del editor o el propietario.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

UNIDAD 6

ÍNDICE

6.1. Paniculitis (celulitis).

6.2. Adiposidades.

6.3. Obesidad.

OBJETIVOS

- Saber lo que es la paniculitis, obesidad y adiposidades y cuáles son las diferencias entre ellas.

6.1. PANICULITIS (CELULITIS)

La celulitis es una patología del tejido subcutáneo en el que se ven afectados los adipocitos por una alteración circulatoria y linfática de la zona. Se manifiesta por la formación de micromódulos que más tarde darán lugar a la conocida piel de naranja.



Se distinguen 4 tipos diferentes:

- Celulitis dura.

La celulitis dura es masiva, compacta e invade los muslos y la pelvis.

Se reconoce por la palpación con la mano, se aprecia un acolchonamiento, puede doler cuando se aprieta ligeramente la zona y con ligeros golpes la piel puede amoratarse y presentar un cardenal.

La zona afectada está rígida y tiene aspecto de una masa compacta. La piel que la recubre tiene más espesor en forma regular y uniforme.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La gran distensión hace que se rompan las fibras elásticas de la piel y aparezcan grietas de color rojizo o blanco.

Afecta a mujeres jóvenes de buen físico, deportistas y bailarinas, con tejidos firmes y tonificados y sin hinchazón, lo que hace difícil su reconocimiento.

Afecta también a mujeres con exceso de peso.



- Celulitis flácida.

La celulitis blanda es más grave, es antiestética y más complicada a la hora de tratarla. Se reconoce a simple vista. Con la celulitis blanda se produce un aumento de volumen, las venas se hinchan y los tejidos se inflaman.

La apariencia de los tejidos afectados por este tipo de celulitis es de poca consistencia y flaccidez, y suele afectar a muslos, caderas y glúteos. Aparece en mujeres de 35 a 45 años.

Los tejidos blandos, debido al poco tono muscular que tienen, producen deformaciones que se hunden y aplastan a la menor presión.

Al andar, se aprecia el balanceo típico de la masa celulítica que tiende a ocupar grandes zonas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Afecta a las personas sedentarias y a aquellas que alguna vez fueron muy activas y ya no lo son.

Afecta también a mujeres que han seguido repetidos y severos tratamientos dietéticos y que han perdido y recuperado peso muy rápida y bruscamente.

- Celulitis edematosa.

La celulitis edematosa es poco frecuente, pero es la más grave.

Las acumulaciones de este tipo de celulitis tienden a hincharse rápidamente y pueden llegar a variar hasta 10 cm. en un solo día.

Suele afectar principalmente a los muslos, y si no se trata adecuadamente, con los años puede degenerar en varices.

Aparece en la pubertad y debe tomarse muy en serio. Se localiza principalmente en las piernas, afectándolas en su totalidad. Se distingue a simple vista.

- Celulitis mixta.

Junto a la manifestación externa “de granos de café”, aparecen también síntomas como dolor, calambres, varicosidades, sequedad de la piel, pesadez, etc.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

¿Que la produce?

Dentro de sus causas existen factores genéticos, hormonales, estrés, sedentarismo, alimentación inadecuada, etc.

¿Dónde se localiza?

La forma más frecuente se localiza en muslos y glúteos, aunque también puede verse en brazos.

¿Como se trata?



Los tratamientos deben ir encaminados a favorecer la circulación sanguínea y linfática, resolver el edema, facilitar la eliminación de la grasa, mejorar la elasticidad cutánea, reducir la sensación dolorosa, etc.

En primer lugar, habrá que hacer una valoración de los hábitos alimentarios y un análisis de composición corporal para determinar el porcentaje de masa grasa, masa muscular y ósea, así como los niveles de agua intracorporeos.

En función de los resultados elaboramos un plan personalizado que suele combinar dieta, ejercicio físico y técnicas médico-estéticas como mesoterapia, radiofrecuencia, drenaje linfático, electroterápica, presoterapia, etc.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Mesoterapia: Consiste en tratar el área afectada con microinyecciones indoloras de medicamentos, que hacen su efecto principalmente en la zona de aplicación.
- Radiofrecuencia: Se alta eficacia en la celulitis flácida, mixta y edematosa.
- Presoterapia: Estimula las vías linfáticas.
- Termoterapia: Calor profundo en la zona afectada.
- Electroterapia: Estimula la circulación arterial y venosa, el tono de la piel, la musculatura de la zona y produce una disminución del tamaño de las células grasas.
- La micropunción con factores de crecimiento previa aplicación de aquellos factores de crecimiento implicados en la celulitis, se realiza la micropunción, permitiendo esta por su mecanismo de actuación, la penetración de los factores a niveles profundos de la piel, consiguiendo así, una mejora significativa de la celulitis.

¿Cómo se mantiene?

Debido a que se trata de una afección crónica que evoluciona por fases, es fundamental cuidarla siempre, con revisiones periódicas.

Es necesario corregir los hábitos que la favorecen: Dieta inadecuada, sedentarismo, prendas muy ajustadas, tabaco, etc.

6.2. ADIPOSIDADES

En esta ocasión vamos a hablar acerca de una problemática por la que pasan la mayor parte de las personas y que lleva a diferentes afecciones físicas que pueden resultar molestas. Estamos haciendo referencia a lo que se conoce como adiposidad localizada.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Muchas cuestiones estéticas y físicas están relacionadas con ésta, pero ¿cuánto sabemos en realidad acerca de la adiposidad localizada? Lo veremos a continuación.

Lo primero que debemos saber es cómo se forma la adiposidad localizada. Esta tiene lugar como consecuencia de un incremento en el tejido graso, tanto en volumen como en cantidad. Sin embargo, no se trata de un incremento absoluto que tenga lugar en muchas partes del cuerpo.

Un error que se comete frecuentemente cuando se intenta entender la adiposidad localizada es confundirla con la celulitis. Es frecuente que la adiposidad localizada dé lugar a la celulitis, pero eso no significa que la última surja necesariamente sólo porque se tiene adiposidad localizada. Al mismo tiempo, es frecuente que se confunda a la adiposidad localizada con la obesidad. En este sentido, es importante plantear diferencias fundamentales.



Cuando hablamos de obesidad estamos haciendo referencia a una serie de factores alimenticios, genéticos y de metabolismo que dan lugar a la misma. Esta, se manifiesta en aumento de tamaño y de grasa en todas partes del cuerpo, generando además

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

diferentes problemáticas, como pueden ser los problemas respiratorios, un aumento en el colesterol, la diabetes, entre otras. Esta diferencia es importante tenerla en cuenta, ya que los tratamientos para ambas cosas son diferentes. Cuando hablamos de obesidad no hablamos de grasa acumulada en pocas partes del cuerpo, por lo que no es algo que pueda tratarse solamente con una liposucción u otro tratamiento estético. La obesidad requiere de modificaciones estructurales en los hábitos alimenticios y de todos los días, como así también el control de la salud de los pacientes.

Por el contrario, la adiposidad localizada es, como su nombre lo indica, la acumulación de grasa en partes puntuales o "localizadas" del cuerpo. Sin embargo, aunque claramente es mucho más sencillo de tratar que la obesidad, se trata de una grasa que no es fácil de eliminar a través de la dieta y el ejercicio físico. En general, la grasa que se conoce como adiposidad localizada suele perdurar, independientemente de los cambios que se realicen en la vida cotidiana. Es por esto que, para eliminarla, suele ser necesario acudir a diferentes procedimientos estéticos o cirugías que la eliminan por completo.

¿En quiénes y en qué partes del cuerpo se da la adiposidad localizada?

Algo que cabe destacar es que la adiposidad localizada tiende a tener lugar tanto en hombres como en mujeres, siendo una problemática que no se relaciona directamente con el sexo biológico de las personas. En las mujeres con frecuencia se distribuye en el área de las caderas y del vientre, como así también puede ser en glúteos y muslos. Por su parte, los hombres suelen tenerla especialmente en el abdomen, como puede ser también en los brazos.

Causas

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Muchos son los factores que pueden dar lugar a que se genere adiposidad localizada. En general se relaciona con hábitos alimenticios que se sostienen de manera prolongada a lo largo del tiempo. Entre las comidas o alimentos que mayormente tienden a generar adiposidad localizada encontramos el exceso de azúcar, las harinas blancas, los alimentos fritos y con demasiada grasa, las bebidas alcohólicas y el tabaco. Claro está que la adiposidad localizada no se va a desarrollar porque se pruebe algo de todo esto de vez en cuando. Sin embargo, sin son hábitos sostenidos, es muy probable que la misma tenga lugar.

Existen múltiples factores que pueden predisponer el acúmulo de grasa localizada, de manera aislada o asociada a sobrepeso u obesidad.

- Factores Hereditarios: La herencia puede predisponer al desarrollo de estos depósitos en abdomen y tronco.
- Factores Genéticos: El sexo masculino predispone al desarrollo de depósitos de grasa en la zona abdominal, con un mayor riesgo cardiovascular asociado.
- Factores adquiridos: Incluyen principalmente factores ali9mentarios, factores endocrinos (principalmente relacionados con hipotiroidismo o síndrome de ovario poliquístico), factores farmacológicos (como estrógenos o corticoides); sedentarismo, hábitos de vida, etc.

La distribución puede ser:

- Adiposidad central o abdominal: Es más frecuente en el hombre y en la mujer postmenopáusica. Esta se en abdomen y flancos y es la denominada disposición en manzana.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Adiposidad periférica o ginoide: La grasa se deposita preferentemente en caderas y glúteos. Es la llamada en forma de “pera”. Se puede asociar a celulitis.

En la mayoría de los casos el tratamiento de elección suele ser lipoescultura o liposucción (lipolaser) que permite la disminución del volumen de manera duradera.

Además, se disponen una serie de herramientas que pueden ser de ayuda al paciente. Siempre es imprescindible iniciar el tratamiento con dieta y cambio de hábitos de vida, ejercicio.



Formas de tratamiento

Muchas son las formas que existen en la actualidad para poder tratar y eliminar la adiposidad localizada. Entre estas, podemos destacar especialmente las siguientes:

- La cavitación.
- Los procedimientos con uso de ultrasonido.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- El drenaje linfático de manera manual.
- La mesoterapia: Mediante la administración de sustancias con efecto lipolítico.
- Carboxiterapia: Administración de dióxido de carbono.

Por otro lado, podemos mencionar una serie de procedimientos que pueden ayudar a que el tratamiento se lleve adelante de mejor manera, favoreciendo y haciendo duraderos los resultados. Podemos mencionar en este punto el uso de vendajes ajustados, la aplicación de compresas frías en las zonas afectadas, la aplicación de elementos con calor durante plazos prolongados para que la grasa se ablande, entre otros factores. Si bien es cierto que rara vez estos resultan suficientes para eliminar por completo la adiposidad localizada, sí es verdad que nos pueden ayudar a optimizar aún más los tratamientos a los que decidamos acudir para eliminarla, haciendo que esto se obtenga mucho más rápido. Al mismo tiempo, es una buena manera -junto con mejorías considerables en los hábitos alimenticios y un aumento en la actividad física aeróbica- de mantener los resultados obtenidos con el paso del tiempo para que la adiposidad localizada no vuelva a formarse en nuestro cuerpo.



6.3. OBESIDAD

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La obesidad es una enfermedad crónica causada por factores muy diversos, tanto genéticos como ambientales, y que provoca un exceso de acumulación de grasa en el cuerpo.

No se trata de un simple problema estético, sino que constituye una verdadera amenaza para nuestra salud, ya que incrementa las posibilidades de sufrir otras enfermedades como diabetes, colesterol, hipertensión, enfermedades articulares, de la vesícula biliar, coronarias y respiratorias, entre otros.



Causas de la obesidad

Este problema de salud, calificado por la OMS como la epidemia del siglo XXI, tiene su origen en causas que van desde la herencia genética, los trastornos endocrinos, la influencia del medio ambiente, problemas del sistema nervioso, el tipo de alimentación o la actividad física. Estos dos últimos factores, alimentación y actividad física, están relacionados con la mayoría de los casos de sobrepeso y obesidad.

Los expertos advierten que la obesidad está aumentando de manera alarmante en los países occidentales como consecuencia del sedentarismo de la vida moderna y los malos hábitos alimenticios. Se cree que en los próximos veinte años el número de

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

obesos se duplicará. En la actualidad, esta enfermedad afecta a más de dos millones de españoles y es un poco más frecuente en las mujeres que en los hombres.

Un 43% de la población española entre 20 y 65 años padece sobrepeso u obesidad. El sobrepeso, a diferencia de la obesidad, no es una enfermedad, aunque debemos tener presente que si no se controla puede acabar derivando en obesidad.

¿Cuál es el PESO ADECUADO?



IMC = peso en kilos / altura en m2

El peso adecuado se puede saber calculando el Índice de Masa Corporal (IMC): El peso en kilos partido por la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona que pese 70 kilos y mida 1,65 metros tendrá un IMC de 70 / 1,65 x 1,65 = 25,72.

Si el resultado se encuentra entre 18,5 y 24,9, el peso se considera normal. Entre 25 y 29,9 se considera sobrepeso y, a partir de 30, obesidad. Además, a partir de 30, se incrementan las posibilidades de padecer determinadas enfermedades. Pero no sólo el grado de obesidad es un factor de riesgo para sufrir patologías diversas, sino que también influye la distribución de grasa en el cuerpo.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Así, cuando se acumula más a nivel abdominal hay un riesgo mayor de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares, y cuando la grasa se acumula a nivel de glúteos y muslos, los problemas asociados no son de tipo metabólico sino más bien estético y localizados a nivel de los miembros inferiores (circulación, artrosis de rodillas, etc.)

- Peso normal → IMC = 18,5-24,9.
- Sobrepeso → IMC = 25-29,9.
- Obesidad → IMC => 30.

Prevención de la obesidad

Aunque los factores genéticos no se pueden modificar, sí podemos incidir en el caso de los factores ambientales.

- Siempre podemos intentar llevar una dieta equilibrada.
- Mantener una actividad física adecuada a las características de cada persona.

Es muy importante tener en cuenta que una vez establecida la obesidad es muy difícil revertirla y se requiere un gran esfuerzo y constancia. Por ello, se dice que la mejor manera de tratar la obesidad es prevenirla.

- La prevención debe comenzar ya desde la infancia, educando a los niños para que aprendan unos hábitos alimenticios correctos y promoviendo la práctica de ejercicio físico desde pequeños. Este aprendizaje infantil es fundamental, ya que condicionará los hábitos del adulto.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Otros periodos en los que hay una tendencia a ganar peso son la adolescencia, el embarazo, la mediana edad en las mujeres y después de casarse en los hombres.

Recomendaciones para prevenir la obesidad

- La primera regla en materia de obesidad es no permitirse engordar. Para prevenirla deberemos llevar una dieta equilibrada y hacer ejercicio de manera regular, en función de la edad y de las características individuales (por ejemplo, practicar gimnasia, natación o simplemente caminar).

- Para adelgazar, es fundamental llevar una dieta equilibrada, comiendo de todo, pero con moderación y en función de las necesidades energéticas de cada uno. Las comidas deberán repartirse en 4 o 5 al día, evitando picar entre horas. Debemos moderar el consumo de grasas animales saturadas, aumentar el consumo de frutas, verduras y pescado, procurar comer despacio y masticar bien.

- Los beneficios de una pérdida de peso, aunque sea pequeña, en una persona obesa, compensan con creces el esfuerzo, ya que se reduce el riesgo de sufrir muchas enfermedades.

Tratamiento de la obesidad

- El tratamiento de la obesidad es un tratamiento para toda la vida.

- En cambio, el tratamiento del sobrepeso puede ser un tratamiento puntual durante unas semanas o meses.

- Ambos tratamientos tienen pautas en común:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Requieren esfuerzo, constancia y estar dispuesto a modificar los hábitos alimentarios.
- El consejo alimentario debe ser siempre individualizado y bajo la dirección de un profesional.
- No debemos confiar en productos “milagro” ni en las dietas “mágicas” que aconsejan personas no expertas.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 6

Medicina estética corporal

